

DERMATOLOGIE & ENDOCRINOLOGIE

Glandes Endocrines & Revêtement Cutané — Fiches QE Haute Fréquence — Version 1

*Cross-match : 550 QEs officielles (2019 → 2026 (11 sessions)) × Cours AIO Dermato + Endocrino 2026 ·
Corrections officielles e-qe.online*

Endocrino : Pr Elmghari · Pr Ansari · Pr Baizri — Dermato : Pr Bouhamidi · Pr Amal · Pr Aboudourib · Pr Hocar —
FMPM 2025–26

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 550 QEs (11 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Diabète	89 Q	Pr. Elmghari
2	Adénome hypophysaire	65 Q	Pr. Ansari
3	IST (syphilis, VIH, écoulement, ulcération)	46 Q	Pr. Bouhamidi
4	Pathologie thyroïdienne & nodule	44 Q	Pr. Baizri
5	Questions transversales (diagnostic différentiel)	41 Q	— (transversal dermato)
6	Sd de Cushing & insuffisance surrénalienne	34 Q	Pr. Ansari
7	Dermatoses bulleuses	30 Q	Pr. Aboudourib
8	Infections cutanées virales (HSV/VZV/HPV/molluscum)	28 Q	Pr. Hocar
9	Cancers cutanés & mélanome	25 Q	Pr. Amal
10	Dermatoses bactériennes	22 Q	Pr. Hocar
11	Mycoses superficielles	21 Q	Pr. Hocar
12	Nutrition clinique	21 Q	Pr. Baizri
13	Obésité	16 Q	Pr. Baizri
14	Toxidermies médicamenteuses	13 Q	Pr. Bouhamidi
15	Eczéma (dermatite atopique + contact)	12 Q	Pr. Hocar
16	Prurit	9 Q	Pr. Aboudourib
17	Acné	8 Q	Pr. Amal
18	Ectoparasitoses & teignes du cuir chevelu	6 Q	Pr. Hocar
19	Erythème noueux	4 Q	Pr. Aboudourib
20	Tuberculose cutanée	3 Q	Pr. Aboudourib
21	Psoriasis	3 Q	Pr. Amal
22	Urticaire	2 Q	Pr. Bouhamidi
23	Lèpre	2 Q	Pr. Aboudourib

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 11 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Diabète	89	8.09	16.2%
Adénome hypophysaire	65	5.91	11.8%
IST (syphilis, VIH, écoulement, ulcération)	46	4.18	8.4%
Pathologie thyroïdienne & nodule	44	4.00	8.0%
Questions transversales (diagnostic différentiel)	41	3.73	7.5%
Sd de Cushing & insuffisance surrénalienne	34	3.09	6.2%
Dermatoses bulleuses	30	2.73	5.5%
Infections cutanées virales (HSV/VZV/HPV/molluscum)	28	2.55	5.1%
Cancers cutanés & mélanome	25	2.27	4.5%
Dermatoses bactériennes	22	2.00	4.0%
Mycoses superficielles	21	1.91	3.8%
Nutrition clinique	21	1.91	3.8%
Obésité	16	1.45	2.9%
Toxidermies médicamenteuses	13	1.18	2.4%
Eczéma (dermatite atopique + contact)	12	1.09	2.2%
Prurit	9	0.82	1.6%
Acné	8	0.73	1.5%
Ectoparasitoses & teignes du cuir chevelu	6	0.55	1.1%
Erythème noueux	4	0.36	0.7%
Tuberculose cutanée	3	0.27	0.5%
Psoriasis	3	0.27	0.5%
Urticaire	2	0.18	0.4%
Lèpre	2	0.18	0.4%
TOTAL des leçons au programme (hors HTA endocrinienne)	544 Q	49.45	98.9%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] DIABETE

Pr. Elmghari • ~8.09 Q/examen — 16% de CHAQUE examen, la leçon n°1

- □ Ref : SFD 2023–24 · CEEDMM · recomedicales.fr (diabete type 1 / type 2)
- Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Criteres du diagnostic POSITIF de diabete :

- Glycemie a jeun (GAJ) veineuse $\geq 1,26$ g/l
- Glycemie aleatoire / post-prandiale ≥ 2 g/l (+ signes)
- HbA1c $\geq 6,5$ %
- Δ Δ GAJ $\geq 0,92$ g/l = seuil du diabete GESTATIONNEL, pas du diabete
- Δ Δ HbA1c $\geq 5,7$ % seule = prediabete
- Δ Δ Cetonurie / glycosurie isolees ≠ critere diagnostique

□ Vu : N2019, N2020, N2022, Nov2024, N2025 (≈chaque session)

Etats PREDIABETIQUES — les 3 seuils :

- Hyperglycemie moderee a jeun (HMJ) : GAJ 1,10–1,25 g/l
- Intolerance au glucose : glycemie 2h post-HGPO 75g entre 1,40 et 1,99 g/l
- HbA1c entre 5,7 et 6,4 %
- Δ Δ Cas type : GAJ 1,24 + HbA1c 6,2 % → HMJ (GAJ $< 1,26$ ET HbA1c $< 6,5$)
- Δ Δ Glycemie post-prandiale 1,69 g/l → intolerance au glucose, pas diabete

□ Vu : N2020, N2024, R2024, N2025 (cas de classification repetes)

L'HbA1c (hemoglobine glyquee) :

- Index valide, reflete la moyenne glycemique des 2–3 derniers mois
- Basee sur la glycation des proteines et de l'hemoglobine
- Exprimee en % ; dosee tous les 3 mois
- -1 point d'HbA1c $\approx$ -16 % de risque d'infarctus du myocarde
- Δ Δ N'est pas exprimee en g/l ni $\mu\text{g/dl}$
- Δ Δ Ne se dose pas chaque semaine

□ Vu : N2019, N2026

L'effet incretine :

- Concerne 2 peptides intestinaux : GLP-1 et GIP
- Implique dans la physiopathologie du DT2
- Explique la difference de secretion d'insuline glucose oral vs IV
- Base des nouveaux traitements (analogues GLP-1, gliptines)
- Δ Δ N'explique pas les hypoglycemies severes
- Δ Δ Pas implique dans le DT1 ni le diabete insipide
- Δ Δ Ce ne sont pas la lipase/amylase

□ Vu : R2019, N2019, R2021, N2024, N2026

L'insulinoresistance (DT2) :

- 1er mecanisme physiopathologique du DT2 (precede l'insulinopenie)
- Concerne MUSCLE squelettique, TISSU ADIPEUX et FOIE
- Peut donner un hyperinsulinisme et, au long cours, une apoptose des cellules beta
- Liee a l'obesite androide/viscerale
- Δ Δ Ne concerne pas cerveau, medullosurrenale, corticosurrenale, hypophyse
- Δ Δ Au foie elle AUGMENTE la neoglucogenese (ne l'inhibe pas)

- **⚠️ ⚠️ Obésité androïde, pas gynoïde**

□ Vu : N2019, R2019, Nov2024, N2025, N2026

Diabète de type 1 :

- Atteinte AUTO-IMMUNE des cellules beta du pancreas ENDOCRINE → insulinocarence
- Avant 30 ans, pic à l'adolescence ; traite par INSULINE
- Début aigu : acidocétose / syndrome cardinal (amaigrissement, appétit conserve)
- Anticorps : anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline, anti-ZnT8
- **⚠️ ⚠️ Pancreas ENDOCRINE, pas exocrine**
- **⚠️ ⚠️ Pas d'insulinorésistance ni d'obésité**
- **⚠️ ⚠️ Pas d'anti-TPO / anti-DNA / anti-muscle lisse**

□ Vu : N2019, R2021, Nov2024, N2026

Diabète cortico-induit :

- ≈ 2 % des diabètes ; dépend de la dose ET de la durée de corticothérapie
- FdR : surcharge pondérale, ATCD familiaux de diabète
- Dépiste par cycle de glycémies capillaires (8h–12h–14h/16h–20h)
- **⚠️ ⚠️ HbA1c seule INSUFFISANTE (diabète récent, post-prandial)**
- **⚠️ ⚠️ Pas de dépistage par CLU**
- **⚠️ ⚠️ Pas 20 % des diabètes**

□ Vu : N2019, R2019

Diabète gestationnel :

- Dépiste par HGPO 75 g entre 24e et 28e SA
- FdR : âge > 35 ans, ATCD personnel de diabète gestationnel
- Risque fœtal : macrosomie + hypoglycémie neonatale
- Risque maternel : DT2 dans le post-partum
- **⚠️ ⚠️ Pas de dépistage par HbA1c à la 8e SA**

□ Vu : R2019, N2019

Etiologies de diabète SECONDAIRE / iatrogène :

- Pancréatiques : pancréatite, cancer/pancreatectomie
- Endocriniennes : acromégalie, Cushing/hypercorticisme, pheochromocytome
- Iatrogènes : corticoïdes, antiretroviraux, psychotropes, interféron alpha
- **⚠️ ⚠️ Maladie d'Addison N'EST PAS une cause (→ hypoglycémie)**
- **⚠️ ⚠️ Insuffisance cardiaque n'est pas une cause**
- **⚠️ ⚠️ Les sulfamides TRAITENT le diabète**

□ Vu : R2021, N2025, N2026

Hyperglycémie de stress vs diabète révélé (cas SCA/IDM) :

- Glycémie élevée à l'admission d'un événement aigu chez non-diabétique
- Bilan : GAJ + HbA1c ; réévaluer à distance
- Si normalisation → stress/HMJ/IGT ; si HbA1c ≥ 6,5 % ou persistance → diabète
- **⚠️ ⚠️ Une glycémie à 2,84 g/l à l'admission peut être un DT2 révélé OU un stress (les deux)**

□ Vu : N2019, N2021, N2022, N2024, N2026 (cas répété)

Rétinopathie diabétique :

- Complication microangiopathique LA PLUS fréquente
- Lésion CARACTÉRISTIQUE du stade prolifératif = NEOVASCULAIRES
- Non-proliférante : microanévrismes, exsudats, nodules cotonneux, œdème maculaire
- Dépistage annuel (FO) ; traitement prolifératif = panphotocoagulation laser
- **⚠️ ⚠️ Aggravée par HTA, anticoagulants, grossesse**
- **⚠️ ⚠️ Réponse unique « stade prolifératif » = neovaisseaux**

□ Vu : N2019, R2021, N2021, Nov2024

Pied diabétique — physiopathologie & types d'ulcère :

- Pathogénie = neuropathie + artériopathie + microtraumatismes + infection
- Ulcère NEUROPATHIQUE : INDOLORE, zone d'hyperpression, hyperkeratose périphérique, poulx PRÉSENTS
- Ulcère ARTERITIQUE : DOULOUREUX, nécrose, poulx ABSENTS
- Avant amputation : échodoppler artériel, radio (ostéite), bilan infectieux, pus
- ⚠️ ⚠️ *Retinopathie/néphropathie ne font pas partie de la pathogénie du pied*
- ⚠️ ⚠️ *Hyperkeratose périphérique n'est pas un critère d'ulcère artéritique*

□ Vu : N2020, N2024, R2024, Nov2024

Neuropathie diabétique périphérique :

- Anesthésie thermo-algique ; atteinte motrice → déformations du pied
- Dépistage principal = test au monofilament (10 g)
- ⚠️ ⚠️ *EMG / échodoppler ne sont pas le dépistage de 1re intention*

□ Vu : N2020

Hypoglycémie (triade de Whipple & signes) :

- Triade de Whipple : glycémie < 0,60 g/l + signes neuroglycopeniques + correction au resucrage
- Signes NEUROGLYCOPENIQUES : diplopie, convulsions, confusion, troubles du comportement
- Causes chez le diabétique : surdosage insuline/sulfamides/glinides, insuffisance surrénale, effort intense
- Hypoglycémies organiques endocriniennes : insulinome, insuffisance surrénale/corticotrope
- ⚠️ ⚠️ *Tremblements/sueurs/palpitations = ADRENERGIQUES, pas neuroglycopeniques*
- ⚠️ ⚠️ *Pheochromocytome et hyperthyroïdie ne donnent pas d'hypoglycémie organique*

□ Vu : N2022

Suivi & objectifs :

- HbA1c trimestrielle ; objectif ≤ 7 % (glycémie pré-prandiale 0,80–1,20 g/l)
- Microalbuminurie annuelle (des le dg en DT2, après 5 ans en DT1)
- Fond d'œil annuel
- ⚠️ ⚠️ *Pas d'ECG trimestriel systématique*

□ Vu : R2021, N2021

[RANG 2] ADENOME HYPOPHYSAIRE

Pr. Ansari • ~5.91 Q/examen

□ □ Ref : SFE · CEEDMM — adénomes hypophysaires / hyperprolactinémie / acromégalie

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Imagerie & classification de taille :

- Examen de RÉFÉRENCE = IRM hypophysaire
- Microadénome < 10 mm ; Macroadénome ≥ 10 mm
- Adénome le PLUS fréquent = prolactinome
- ⚠️ ⚠️ *Pas radio de selle turcique, scanner cérébral, ni octreoscan pour classer*
- ⚠️ ⚠️ *« Picoadénome » n'existe pas*

□ Vu : N2020, R2021, N2021, N2022, N2024

Syndrome tumoral selon l'extension :

- SUPRA-sellaire → compression du chiasma → anomalies du champ visuel ; céphalées (frontotemporales, rétro-orbitaires par étirement du diaphragme sellaire)
- LATERO-sellaire → sinus caverneux → diplopie, strabisme, ophtalmoplogie (III, IV, VI)
- ⚠️ ⚠️ *Diplopie/strabisme = sinus caverneux (latérosellaire), pas suprasellaire*
- ⚠️ ⚠️ *La diplopie n'est pas constante dans le macroadénome*

□ Vu : R2021, N2021, N2022, N2025, N2026

Hyperprolactinémie — diagnostic biologique :

- UN dosage de prolactinémie de base simple, à n'importe quelle heure
- Macroprolactinémie : PRL souvent > 200 ng/ml (ex. 500 ng/ml + macroadénome)
- Hyperprolactinémie de DECONNEXION : macroadénome non sécrétant comprimant la tige → PRL modérément élevée
- ⚠️ ⚠️ Pas de test TRH, ni dosage stimulé, ni 3 dosages répétés
- ⚠️ ⚠️ Gros adénome + PRL peu élevée = déconnexion, pas prolactinémie

□ Vu : N2020, R2024, Nov2024

Avant de retenir un adénome : éliminer une hyperprolactinémie secondaire :

- Médicaments (neuroleptiques, antidépresseurs, antiémétiques)
- Insuffisance rénale ; hypothyroïdie primaire ; grossesse ; stress
- ⚠️ ⚠️ Paracétamol, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatocellulaire ne donnent pas d'hyperprolactinémie

□ Vu : N2024, N2026

Manifestations & gynécomastie :

- Femme : amenorrhée, galactorrhée, infertilité — Homme : dysfonction érectile, baisse de libido, gynécomastie, atrophie testiculaire
- Gynécomastie = insuffisance gonadotrope → balance œstrogènes/testostérone EN FAVEUR des œstrogènes
- Gynécomastie pathologique : hypogonadisme, homme adulte, galactorrhée associée
- ⚠️ ⚠️ Pas un effet DIRECT de la PRL sur le sein, ni un excès de testostérone
- ⚠️ ⚠️ Physiologique : nouveau-né, puberté

□ Vu : N2020, R2021, N2025

Acromégalie (adénome somatotrope) — clinique & diagnostic :

- Syndrome dysmorphique facial, doigts boudinés, raucité de la voix, protubérance occipitale, cyphoscoliose, hépatomégalie
- Diagnostic = GH NON freinée sous HGPO + IGF-1 élevée
- Enfance + persistance = acrogigantisme
- Comorbidités : diabète, goitre, HTA, SAOS, cardiopathie, dyslipidémie, articulations
- ⚠️ ⚠️ Pas le test GHRH, point isolé de GH, ni hypoglycémie insulinaire
- ⚠️ ⚠️ Bosse de bison = Cushing, pas acromégalie

□ Vu : R2021, N2021, N2024, R2024

Traitement selon le type — LE piège thérapeutique :

- Prolactinome (micro ET macro) : agonistes dopaminergiques en 1^{re} intention (cabergoline, bromocriptine)
- Acromégalie : chirurgie trans-sphénoïdale + analogues de la somatostatine
- Chirurgie 1^{re} intention : maladie de Cushing, acromégalie, macroadénome non fonctionnel COMPRESSIF
- Microadénome non sécrétant non compressif : surveillance
- ⚠️ ⚠️ Le prolactinome (même macro) ne relève PAS de la chirurgie 1^{re} → traitement MEDICAL
- ⚠️ ⚠️ Pas de somatostatine pour le prolactinome ; pas d'agonistes dopa en 1^{re} pour l'acromégalie

□ Vu : N2020, R2021, N2021, N2024, R2024, N2025, N2026

[RANG 3] IST — SYPHILIS, VIH, ÉCOULEMENT & ULCÉRATION GÉNITALE

Pr. Bouhamidi • ~4.18 Q/examen

□ □ Ref : recomedicales.fr (syphilis, IST) · CMIT · OMS

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Toute ulceration genitale aigue :

- Est une IST jusqu'a preuve du contraire ET une urgence diagnostique
- Bilan IST systematique (TPHA-VDRL, serologie VIH...)
- ⚠️⚠️ Pas « toujours syphilitique » ni « benigne »

□ Vu : N2026

Chancre syphilitique vs chancre mou :

- Chancre SYPHILITIQUE (T. pallidum) : UNIQUE, INDOLORE, INDURE, fond propre, incubation ≈ 3 sem (10–90 j)
- Chancre MOU (H. ducreyi) : DOULOUREUX, sale/purulent, mou, multiple, incubation courte (3–5 j)
- Traitement chancre mou : azithromycine 1 g PO ou ceftriaxone 250 mg IM ou ciprofloxacine 500 mg, dose unique
- ⚠️⚠️ Une ulceration douloureuse purulente = chancre mou, PAS syphilitique
- ⚠️⚠️ Parmi herpes/chancre mou/aphte/syphilis, seule la syphilis est typiquement INDOLORE

□ Vu : N2019, N2022, R2024, N2025, N2026

Ulcerations genitales A REPETITION :

- Herpes genital, aphtose genitale, erytheme pigmenté fixe bulleux (toxidermie)
- ⚠️⚠️ La syphilis (chancre) et le chancre mou ne RECIDIVENT pas a repetition

□ Vu : N2020, R2021, Nov2024

Ecoulement uretral :

- Purulent, abondant, incubation courte (2–5 j) → uretrite GONOCOCCIQUE (N. gonorrhoeae)
- Clair/minime, incubation plus longue (7–15 j) → uretrite a chlamydia / mycoplasme (non gonococcique)
- Traitement gonococcie : ceftriaxone 500 mg IM + doxycycline 200 mg/j x 7 j (co-traiter chlamydia)
- Germes des uretrites : gonocoque, Chlamydia trachomatis, Trichomonas
- ⚠️⚠️ Treponema pallidum et Candida ne sont pas des germes d'uretrite

□ Vu : R2021, R2024, N2024, N2025, N2026

Serologie syphilitique (VDRL / TPHA) :

- VDRL = non treponemique (Ag cardiolipidique non specifique), le VDRL quantitatif suit l'evolution/traitement
- TPHA = treponemique specifique
- VDRL– TPHA– : elimine la syphilis ; VDRL– TPHA+ : peut se voir en syphilis tertiaire/cicatrice
- VDRL+ TPHA+ asymptomatique = syphilis latente
- ⚠️⚠️ VDRL+ TPHA– = FAUX POSITIF (pas une syphilis latente) → chez la femme enceinte avec examen normal : rassurer (apres controle)
- ⚠️⚠️ Latente precoce (<1 an) : 1 injection benzathine penicilline 2,4 MU ; tardive : 3 injections hebdomadaires

□ Vu : N2021, N2022, N2024, Nov2024

VIH — primo-infection & manifestations cutanees :

- Primo-infection : 2–3 sem post-exposition, exantheme maculo-papuleux/scarlatiniforme + enantheme + fièvre ± signes neurologiques
- Confirmation : charge virale VIH (Western blot encore negatif en fenetre)
- Manifestations cutanees : a TOUS les stades, parfois revelatrices, valeur pronostique
- Dermatoses faisant demander une serologie VIH : molluscum etendu, zona du sujet jeune, chancre, Kaposi
- ⚠️⚠️ L'exantheme n'est pas constant, n'est pas toujours prurigineux, n'epargne pas les muqueuses
- ⚠️⚠️ Manifestations cutanees PAS toujours tardives ni toujours infectieuses

□ Vu : N2020, R2021, N2026

Ulcerations / lesions au stade SIDA :

- Ulceration perineale/peri-anale chronique : herpes, carcinome epidermoide, ulceration a CMV
- Papules perlees ombiliquees : molluscum contagiosum (etendu)

- Papules angiomateuses : maladie de Kaposi, angiomatose bacillaire, histoplasmosse
- ⚠️ ⚠️ Une ulcération chronique au stade SIDA n'est pas anodine : penser carcinome épidermoïde et CMV

□ Vu : N2021, N2022, R2024, N2024, N2025

Condylomes & HPV ano-génitaux :

- Bilan : sérologie VIH + TPHA-VDRL + frottis cervico-vaginal
- Traitement : électrocoagulation, podophyllotoxine, cryothérapie, imiquimod
- Le vaccin HPV est PREVENTIF (ne traite pas les lésions existantes)
- ⚠️ ⚠️ Le vaccin 16/18 ne guérit pas les condylomes déjà présents

□ Vu : N2021

[RANG 4] PATHOLOGIE THYROIDIENNE & NODULE

Pr. Baizri • ~4.00 Q/examen

□ □ Ref : SFE · CEEDMM · EU-TIRADS (nodule) · recomedicales.fr (hypo/hyperthyroïdie)

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Syndrome thyrotoxique & diagnostic de thyrotoxicose :

- Syndrome thyrotoxique = ensemble des manifestations cliniques d'une HYPERTHYROÏDIE, commun à toutes les étiologies
- Diagnostic biologique de 1^{re} intention = couple TSH/LT4 (puis TSH/LT3 si LT4 normale)
- Hyperthyroïdie PATENTE : TSH basse + LT4 (ou LT3) élevée
- Hyperthyroïdie FRUSTE : TSH basse, LT4 et LT3 normales
- ⚠️ ⚠️ Le syndrome thyrotoxique seul ne suffit pas à poser le diagnostic (biologie indispensable)
- ⚠️ ⚠️ Les Ac anti-TPO ne sont pas le 1^{er} examen (étiologie après dg positif)

□ Vu : R2019, R2021, N2024, R2024, N2025, N2026

Manifestations cardio-vasculaires de l'hyperthyroïdie :

- Tachycardie sinusale permanente, palpitations de repos
- ACFA (arythmie complète par FA)
- Insuffisance cardiaque à DÉBIT ÉLEVÉ
- ⚠️ ⚠️ Pas de bradycardie, pas d'IC à FE basse, pas d'AOMI, pas de souffle diastolique

□ Vu : R2019, R2021

Maladie de Basedow & nodule chaud toxique :

- Basedow plus fréquente chez la FEMME ; diagnostic positif = Ac anti-RECEPTEURS de la TSH (TRAK)
- Aspect « Thyroid inferno » (hypervascularisation diffuse) au doppler = Basedow
- Nodule chaud toxique à la scintigraphie I123 = hyperfixation LOCALISÉE avec EXTINCTION du reste du parenchyme
- 3 étiologies principales d'hyperthyroïdie : Basedow, nodule toxique, goitre multinodulaire toxique
- ⚠️ ⚠️ Basedow : PAS le diagnostic par anti-TPO/anti-Tg (ce sont surtout Hashimoto)
- ⚠️ ⚠️ Pas plus fréquente chez le sujet âgé/enfant
- ⚠️ ⚠️ Cancer thyroïdien et thyroidites ne sont pas dans le trio principal

□ Vu : N2021, N2024, R2024, Nov2024, N2025, N2026

Hypothyroïdie — généralités & clinique :

- Majoritairement d'origine PÉRIPHÉRIQUE ; plus fréquente chez la femme
- Clinique (patente) : frilosité, constipation, rauque voix, hypoacousie, macroglossie, ralentissement psychomoteur, prise de poids
- ⚠️ ⚠️ N'est pas rare au Maroc
- ⚠️ ⚠️ Amaigrissement / diarrhée = signes d'HYPERTHYROÏDIE, pas d'hypothyroïdie

□ Vu : R2019, N2019, R2021, N2020

Étiologies des hypothyroïdies PÉRIPHÉRIQUES :

- Thyroidites auto-immunes (Hashimoto = 1re cause auto-immune chez la femme), thyroidite du post-partum
- Thyroïdectomie totale, irradiation cervico-thoracique
- Carence iodee, surcharge iodee
- ⚠️ ⚠️ *Le pan-hypopituitarisme est une cause CENTRALE, pas peripherique*
- ⚠️ ⚠️ *Basedow et goitre multinodulaire toxique = hyperthyroidie*
- ⚠️ ⚠️ *Pas la « surcharge en zinc »*

□ Vu : N2020, N2024, R2024, Nov2024, N2025, N2026

Nodule thyroidien :

- Frequent ; cancreux dans ≈ 5 % des cas (majorite benins)
- Bilan : echographie cervicale systematique + classification EU-TIRADS (imperative) + TSH
- Si TSH basse → scintigraphie ; cytoponction echoguidee : EU-TIRADS 5 >5 mm, EU-TIRADS 4 >10 mm, EU-TIRADS 3 >20 mm
- ⚠️ ⚠️ *Classification EU-TIRADS, PAS BIRADS (sein) ni Bethesda (= cytologie)*
- ⚠️ ⚠️ *Scintigraphie si TSH BASSE (pas si TSH elevee)*
- ⚠️ ⚠️ *Pas de chirurgie systematique sur la seule taille, quel que soit le TIRADS*

□ Vu : N2019, N2020, N2021, Nov2024, N2025, N2026

[RANG 5] QUESTIONS TRANSVERSALES — DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DERMATO

— (transversal dermato) • ~3.73 Q/examen — questions integratives de raisonnement

□ □ Ref : CEDEF (College des Enseignants de Dermatologie) · recomedicales.fr

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Lesions VESICULEUSES (le piege du « sauf ») :

- Vesiculeuses : herpes, varicelle, zona, eczema, gale, dermatophytie (bordure), erytheme polymorphe
- ⚠️ ⚠️ *Molluscum contagiosum = PAPULE (non vesiculeux)*
- ⚠️ ⚠️ *Urticaire = papule oedemateuse (non vesiculeux)*

□ Vu : N2019, N2020

Plaque erythemato-squameuse / squameuse du CUIR CHEVELU :

- DD : psoriasis, eczema (dermite seborrheique), teigne
- Prurit du cuir chevelu de l'enfant : pediculose (lentes), folliculite, dermite seborrheique, etat pityriasique
- ⚠️ ⚠️ *Pelade = alopecie NON squameuse ; urticaire ≠ squameux*

□ Vu : R2019, N2020, N2021, R2021

Plaques erythemato-squameuses chroniques (coudes/genoux, >10 ans) = PSORIASIS :

- Diagnostic le plus probable ; evolution par poussees
- CAT chez un hypertendu : conseiller l'arret du tabac + dermocorticoides
- Psoriasis : traitement topique 1re intention = dermocorticoides + analogue de vitamine D (calcipotriol)
- ⚠️ ⚠️ *Ne pas arreter l'inhibiteur calcique (ne donne pas de psoriasis) ; ce sont les BB et IEC qui aggravent*
- ⚠️ ⚠️ *Pas de biopsie systematique (diagnostic clinique) ; pas de corticothérapie orale (risque de rebond)*

□ Vu : N2020, N2022, N2024, Nov2024, R2024, N2026

Signes unguaux & autres semiologies transversales :

- Bande pigmentee unguale s'etendant au repli proximal (signe de Hutchinson) → MELANOME unguaal
- Pachyonychie (hyperkeratose sous-unguaale) : psoriasis, onychomycose
- Atteinte articulaire + dermatose : psoriasis, syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, gonococcie, erytheme noueux
- ⚠️ ⚠️ *Hematome unguaal ne s'etend pas au repli et migre distalement*
- ⚠️ ⚠️ *Urticaire aigue ne donne pas d'atteinte articulaire*

□ Vu : N2021, N2024

Urgences dermatologiques & risque de cecite :

- Erythrodermie (urgence) : dermatite atopique, psoriasis, toxidermie
- Risque de CECITE : syndrome de Lyell, Stevens-Johnson, erytheme polymorphe (majeur), pemphigoïde cicatricielle
- ⚠️⚠️ Impetigo bulleux et « erysipele generalise » ne sont pas des causes d'erythrodermie
- ⚠️⚠️ La gale ne donne pas de cecite

□ Vu : N2020, R2021

DD des plis & lésions infantiles classiques :

- Plis : erythrasma (brunatre, Wood rouge corail) vs candidose (depots blanchatres, pustules satellites) vs dermatophytie vs psoriasis inverse
- Nourrisson + pustules palmoplantaires + fratrie qui se gratte = gale
- Enfant + erosions labio-gingivales aiguës + fièvre + adenopathie = primo-infection herpétique
- Croutes melicériques peri-orificielles, apyrexie = impetigo
- ⚠️⚠️ « Depots blanchatres » des plis → candidose (pas erythrasma)

□ Vu : R2019, N2021, N2024, Nov2024, N2025, N2026

[RANG 6] Sd DE CUSHING & INSUFFISANCE SURRENALIENNE

Pr. Ansari • ~3.09 Q/examen (23 + 11 fusionnees)

□ □ Ref : SFE · CEEDMM — hypercorticisme / insuffisance surrenale

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

CONFIRMER l'hypercorticisme (= perte du rythme circadien & non-freinabilite) :

- Cortisol libre urinaire (CLU) sur 24h + creatininurie associee
- Cortisol de minuit (salivaire ou plasmatique ; catheter prealable si plasmatique)
- Freinage MINUTE a la dexamethasone (1 mg) — non-freinage = positif
- ⚠️⚠️ Le cortisol de 8h SEUL ne confirme pas (rythme circadien) ; il sert a l'insuffisance surrenale
- ⚠️⚠️ CLU sur 24h (pas 12h) ; pas de natriurese ni de dexamethasone la veille du CLU

□ Vu : R2019, N2019, N2020, N2026

LOCALISER apres confirmation = dosage de l'ACTH plasmatique :

- ACTH elevee/normale-haute → ACTH-DEPENDANT : maladie de Cushing (adenome corticotrope) ou ACTH ectopique
- ACTH basse → ACTH-INDEPENDANT (surrealien) → TDM surrenalienne
- ACTH-dependant : IRM hypophysaire + TDM thoracique fines coupes + octreoscan
- ⚠️⚠️ L'ACTH aide a LOCALISER, il ne confirme pas l'hypercorticisme

□ Vu : R2019, N2019, N2020, N2025, N2026

Causes ACTH-dependantes vs ACTH-independantes :

- ACTH-DEPENDANTES : maladie de Cushing (adenome corticotrope, micro/macro), tumeur neuroendocrine ectopique secretant l'ACTH
- ACTH-INDEPENDANTES : adenome cortisolique, corticosurrenalome, hyperplasie nodulaire des surrenales
- ⚠️⚠️ Tumeur surrenalienne et ectopie secretant le CORTISOL ne sont pas ACTH-dependantes
- ⚠️⚠️ Adenome cortisolique = surrealien (independant), pas une maladie de Cushing

□ Vu : R2019, N2019, N2024, N2026

Maladie de Cushing & signe distinctif clinique :

- Maladie de Cushing = ACTH-dependante, adenome corticotrope (micro/macro), signes d'hypercatabolisme
- Traitement 1re intention = exereses chirurgicales par voie TRANS-SPHENOIDALE

- La MELANODERMIE / hyperpigmentation (par excès d'ACTH/MSH) ne s'observe QUE dans l'hypercorticisme ACTH-dépendant
- ⚠️ ⚠️ *La maladie de Cushing ne se diagnostique pas par le cortisol de 8h*
- ⚠️ ⚠️ *Absence de melanoderme → oriente vers une origine surrenalienne (indépendante)*

□ Vu : R2019, N2019, N2022, N2025, N2026

Clinique de l'hypercorticisme & complications :

- Obésité facio-tronculaire, membres greles, vergetures pourpres larges, HTA, hirsutisme
- Complications : diabète, maladies cardio-vasculaires, atteinte rhumatologique (ostéoporose), respiratoire (SAOS), infections
- ⚠️ ⚠️ *Pas de tremblements, ni myxoedème, ni fièvre chronique*
- ⚠️ ⚠️ *La pancréatite ne fait pas partie des complications du Cushing*

□ Vu : N2020, N2025, N2026

Cushing EXOGENE (iatrogène) :

- Cause la plus fréquente d'hypercorticisme ; tableau biologique OPPOSE à l'endogène (ACTH et cortisol BAS, axe freiné)
- Peut se décompenser en insuffisance surrenale aiguë à l'arrêt brutal
- ⚠️ ⚠️ *Tableau hormonal oppose : ce n'est pas une hypersecretion mais une freination de l'axe*

□ Vu : N2025

Insuffisance surrenalienne — confirmation & tests :

- Insuffisance PÉRIPHÉRIQUE (Addison) : ACTH ÉLEVÉ + cortisolémie de 8h BASSE
- Si cortisol de 8h non franchement bas → test au Synacthène / hypoglycémie insulémique
- ⚠️ ⚠️ *Le test de FREINAGE est pour le Cushing, pas pour l'insuffisance surrenale*

□ Vu : R2019, N2019, N2020

Etiologies de l'insuffisance surrenale :

- Périphériques (Addison) : auto-immune (1^{re} cause, ex. avec DT1), tuberculose surrenalienne, hémorragie bilatérale, infiltration/métastases
- Centrales (déficit corticotrope) : micro/macroadénome, radiothérapie hypophysaire, nécrose hémorragique (Sheehan), traumatisme crânien grave
- ⚠️ ⚠️ *L'adénome cortisolique cause un Cushing, pas une insuffisance*

□ Vu : R2019, N2019, N2020

Clinique & substitution selon le niveau :

- ADDISON (périphérique) : melanoderme, appétence pour le sel, hyponatrémie + HYPERkaliémie ; substitution = hydrocortisone + FLUDROCORTISONE, régime NORMOSALE
- Déficit CORTICOTROPE (central) : pas de melanoderme, pas de déficit mineralocorticoïde ; substitution = hydrocortisone SEULE
- Hydrocortisone orale quotidienne ; éducation (doublement des doses en cas de stress, ne jamais arrêter)
- ⚠️ ⚠️ *Addison : PAS de régime sans sel, PAS de potassium per os (déjà hyperkaliémique), pas d'injection hebdomadaire*
- ⚠️ ⚠️ *Déficit corticotrope : pas besoin de fludrocortisone (aldostérone préservée)*

□ Vu : R2019, N2019, N2020

[RANG 7] DERMATOSES BULLEUSES

Pr. Aboudourib • ~2.73 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF — dermatoses bulleuses auto-immunes (pemphigus, pemphigoïde, DH)

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

PEMPHIGUS (vulgaire/profond) :

- Dermatose bulleuse auto-immune INTRA-épidermique ; bulles FLASQUES sur peau normale

- Atteinte MUQUEUSE fréquente (érosions buccales/genitales, souvent révélatrices)
- Signe de Nikolsky POSITIF ; cellules ACANTHOLYTIQUES (cytodiagnostic de Tzanck)
- Auto-Ac anti-desmogleine (1/3) ; dépôts d'IgG à la surface des kératinocytes (IFD)
- ⚠️ ⚠️ *Le pemphigus est INTRA-épidermique (pas sous-épidermique)*
- ⚠️ ⚠️ *Auto-Ac anti-desmogleine, PAS anti-collagène VII (= EBA)*

□ Vu : R2019, N2019, N2021, N2026

PEMPHIGOÏDE BULLEUSE :

- Sujet AGE ; bulles TENDUES sur peau érythémateuse ; PRURIT intense ; lésions urticariennes
- RESPECTE habituellement les muqueuses ; signe de Nikolsky NEGATIF
- Bulle SOUS-épidermique ; hypereosinophilie ; dépôt linéaire d'IgG + C3 sur la membrane basale (IFD)
- Traitement 1^{re} intention : DERMOCORTICOIDES très forts (clobetasol) ± corticothérapie orale
- ⚠️ ⚠️ *Pas de cellules acantholytiques (≠ pemphigus) ; pas d'antibiotiques anti-staph ni aciclovir*

□ Vu : R2021, R2024, Nov2024, N2025, N2026

DERMATITE HERPÉTIFORME :

- Adolescent/adulte jeune ; vésicules prurigineuses groupées « en bouquet » sur les faces d'EXTENSION (coudes, genoux, fesses)
- Associée à la maladie coeliaque ; Nikolsky négatif ; dépôts GRANULEUX d'IgA (papilles dermiques, IFD)
- Traitement : Disulone (dapsone) + régime sans gluten
- ⚠️ ⚠️ *Atteinte des faces d'extension, sans atteinte muqueuse*

□ Vu : R2019, R2021, N2022

Epidermolyse bulleuse acquise (EBA) :

- Bulle sous-épidermique ; auto-Ac anti-COLLAGÈNE VII ; grains de milium + cicatrices atrophiques ; fragilité mécanique
- ⚠️ ⚠️ *Devant des bulles laissant des grains de milium sur les zones de friction → penser EBA*

□ Vu : N2019, N2022

Signe de NIKOLSKY positif :

- Pemphigus ; syndrome de Lyell (NET) ; epidermolyse staphylococcique (SSSS)
- ⚠️ ⚠️ *NEGATIF dans pemphigoïde bulleuse, dermatite herpétiforme, dermatose à IgA linéaire*

□ Vu : N2021, N2025, N2026

Confirmation diagnostique d'une dermatose bulleuse :

- Biopsie d'une bulle récente (histologie) + biopsie de peau PÉRI-lésionnelle pour IFD + recherche d'Ac circulants (IFI)
- ⚠️ ⚠️ *Pas les Ac antinucléaires, ni les IgE totales, ni les patch-tests, ni le Tzanck seul*

□ Vu : N2024, Nov2024, N2026

[RANG 8] INFECTIONS CUTANÉES VIRALES (HSV / VZV / HPV / MOLLUSCUM)

Pr. Hocar • ~2.55 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF — herpes, zona/varicelle, verrues, molluscum

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Primo-infection herpétique (gingivostomatite) :

- Le plus souvent HSV1, chez l'enfant ; asymptomatique dans ≈ 90 %, patente dans 10 % ; incubation ≈ 1 semaine ; souvent bénigne
- Prise en charge nourrisson : aciclovir systémique si besoin chez l'enfant + traitement topique chez la mère
- ⚠️ ⚠️ *Inversion piège : « asymptomatique 10 % / patente 90 % » est FAUX*
- ⚠️ ⚠️ *Pas due à HSV2, incubation ≠ 2 mois*

□ Vu : N2019, N2020, N2024, Nov2024, N2025

Traitement preventif (suppressif) de l'herpes :

- Indique si > 6 recurrences/an ; valaciclovir 500 mg/j pendant 6 a 12 mois
- ⚠️ Les seuils « >3 genitales » ou « >2 orofaciales » sont faux ; non contre-indique chez la femme enceinte/nouveau-ne

□ Vu : N2019, N2024, Nov2024, R2024, N2025

Zona (reactivation VZV) :

- Eruption vesiculeuse METAMERIQUE, unilaterale, sur un territoire sensitif (ex. hemi-ceinture, douleur a type de brulure)
- Zona OPHTALMIQUE (V1) = urgence ophtalmologique
- Chez le sujet jeune ou immunodeprime (chimiotherapie, Hodgkin) → rechercher une infection VIH
- ⚠️ Devant un zona du sujet jeune : serologie VIH en priorite

□ Vu : R2019, N2020, N2024, Nov2024, N2025

Varicelle (primo-infection VZV) :

- Contagieuse ; eruption vesiculeuse d'ages differents ; BENIGNE chez l'enfant, SEVERE chez l'adulte/immunodeprime/femme enceinte
- Complications : pneumopathie varicelleuse, ataxie cerebelleuse, encephalite, surinfection bacterienne, syndrome de Reye (aspirine)
- Varicelle gravidique → syndrome de varicelle congenitale : microphthalmie, microcephalie, cicatrices depimees achromiques, hypoplasie de membre
- ⚠️ Due au VZV (pas HSV1, pas HPV) ; eviter l'aspirine (Reye)

□ Vu : N2019, R2019, R2021, N2024, Nov2024, N2025, N2026

Molluscum contagiosum (poxvirus) :

- Tumeur cutanee benigne virale ; plus frequent chez l'ENFANT ; papules perlees, fermes, ombiliquees (1–6 mm), possibles sur muqueuses
- ⚠️ N'atteint pas « essentiellement l'adulte immunocompetent » (forme etendue/adulte → penser immunodepression)

□ Vu : R2019, R2024, N2024, N2025

Verrues (HPV) :

- Verrues vulgaires : enfant, mains/avant-bras
- Myrmecie : verrue plantaire ENDOPHYTIQUE DOULOUREUSE (HPV1)
- ⚠️ La myrmecie n'est pas une verrue superficielle ni un durillon

□ Vu : R2019, N2024

[RANG 9] CANCERS CUTANES & MELANOME

Pr. Amal • ~2.27 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF · INCa — carcinomes cutanes / melanome

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Carcinome BASOCELLULAIRE (CBC) — le stem le plus repete :

- Lesion nodulaire TRANSLUCIDE TELANGIECTASIQUE du visage/front/cuir chevelu evoluant depuis 2–3 ans → CBC
- Cancer cutane le plus frequent ; malignite LOCALE, ne metastase PAS ; zones photo-exposees ; traitement chirurgical
- Bilan d'extension : AUCUN
- ⚠️ Une lesion nodulaire translucide telangiectasique = CBC (pas carcinome epidermoide, pas melanome achromique)

□ Vu : N2020, N2022, R2024, N2024, N2026 (repete)

Carcinome EPIDERMOÏDE (CE / spinocellulaire) :

- Lésion ULCERO-VEGETANTE (cuir chevelu, levre inférieure) évoluant 2 ans → CE
- Survient le plus souvent sur une lésion PRECANCEREUSE ; aspect ulcero-vegetant ; PEUT metastaser
- Confirmation : biopsie cutanée ; bilan d'extension : échographie abdominale + radio thorax
- ⚠️ ⚠️ *Le CE ne respecte pas les muqueuses et DONNE des metastases ; traitement = chirurgie (pas essentiellement chimiothérapie)*

□ Vu : N2019, N2021, R2024, N2024, N2025

Lesions PRECANCEREUSES & keratoses actiniques :

- Keratoses actiniques : taches rugueuses brunâtres, zones photo-exposées, phototype clair (agriculteurs) → se transforment en CE ; traitement cryothérapie/5-FU/imiquimod
- Autres precancereuses : corne cutanée, leucoplasie (levre), maladie de Bowen, radiodermite, melanose de Dubreuilh
- ⚠️ ⚠️ *Les keratoses actiniques se transforment en CARCINOME EPIDERMOÏDE (pas CBC, pas melanome)*
- ⚠️ ⚠️ *La keratose seborrheique est BENIGNE (non precancereuse)*

□ Vu : N2020, R2021, N2026

MELANOME :

- Survient le plus souvent sur un naevus PRE-EXISTANT (ou de novo) ; malignité GÉNÉRALE (metastase)
- Au Maroc : siège le plus souvent au niveau PLANTAIRE (melanome acral) ; peut atteindre les ONGLES et le cuir chevelu
- Devant une macule pigmentée plantaire → éliminer en premier un melanome
- FdR : phototype clair, ATCD familial de melanome, naevus congenital géant, naevus multiples, expositions solaires
- ⚠️ ⚠️ *Le melanome N'EST PAS a malignité locale (il metastase)*
- ⚠️ ⚠️ *La prevention n'est pas d'enlever tous les naevus systematiquement (= photoprotection + surveillance ABCDE)*
- ⚠️ ⚠️ *FdR : pas le tabac, pas l'HPV*

□ Vu : N2019, R2021, N2021, N2022, N2024, Nov2024, N2026

[RANG 10] DERMATOSES BACTERIENNES

Pr. Hocar • ~2.00 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF — infections cutanées bactériennes (staph/strepto)

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Folliculites / furoncle / anthrax (Staphylococcus aureus) :

- Folliculite superficielle : pustule centrée par un poil + macule érythémateuse ; favorisée par dermocorticoïdes et obésité ; pas toujours d'ATB général
- Furoncle : folliculite profonde nécrosante (bourbillon) ; traitement anti-staph (acide fusidique, pénicilline M)
- Anthrax : agglomérat de furoncles (nuque/dos), chez le diabétique, avec fièvre/AEG
- Furoncle du VISAGE manipulé → staphylococcie maligne de la face (urgence)
- ⚠️ ⚠️ *Ne JAMAIS inciser/manipuler un furoncle centro-facial (risque de staphylococcie maligne)*

□ Vu : R2019, N2019, R2021, N2024, N2026

Panaris :

- Infection péri-unguée à Staphylococcus aureus ; peut se compliquer d'arthrite/ostéite
- ⚠️ ⚠️ *Ne siège pas « essentiellement au visage » et n'est pas due à un strepto ; n'est pas centrée par une pustule folliculaire (≠ folliculite)*

□ Vu : R2019, N2019

Impetigo :

- Contagieux, bacterien ; croutes MELICERIQUES peri-orificielles ; apyrexie, bon etat general (enfant)
- Impetigo bulleux : bulle superficielle (exfoliatine staphylococcique), nourrisson, fratrie atteinte
- Peut se compliquer de glomerulonephrite post-streptococcique (bandelette urinaire a 3 semaines)
- ⚠️ ⚠️ *Devant des croutes meliceriques chez l'enfant apyretique → impetigo (pas furoncle, pas eczema)*

□ Vu : R2021, N2022

Erysipele (dermo-hypodermite, streptocoque A) :

- Placard rouge chaud douloureux bien limite de jambe, fièvre 38,5–40 °C, lymphangite, porte d'entree (intertrigo/plaie)
- Traitement : penicilline G IV 12–20 MU/j jusqu'a l'apyrexie puis relais oral ; si allergie aux betalactamines → macrolide
- Hospitalisation : fièvre >40/sepsis, polypnee, decollement bulleux etendu, signes de purpura/necrose, comorbidites (diabete), doute avec fasciite
- ⚠️ ⚠️ *La CREPITATION n'existe JAMAIS dans l'erysipele simple (= gaz → fasciite necrosante)*
- ⚠️ ⚠️ *Pas d'AINS (risque de fasciite necrosante), pas de corticoides*

□ Vu : R2019, N2020, N2021, N2022

SSSS (epidermolyse staphylococcique aigue) :

- Enfant ; decollement diffus, signe de Nikolsky POSITIF, RESPECTE les muqueuses ; complique un foyer staph ; clivage sous-corne
- ⚠️ ⚠️ *Respecte les muqueuses (≠ Lyell), pas de grains de milium*

□ Vu : N2020

Autres : anite streptococcique & erythrasma :

- Anite/dermite peri-anale streptococcique (enfant) : erytheme bien limite ; ATB general 3 semaines ; bandelette urinaire a 3 semaines
- Erythrasma : Corynebacterium minutissimum, plis (aisselle/aîne) brunatres, fluorescence ROUGE CORAIL a la lampe de Wood, diabetique
- ⚠️ ⚠️ *Erythrasma (depots absents) vs candidose des plis (depots blanchatres + pustules satellites)*

□ Vu : N2024, N2026

[RANG 11] MYCOSES SUPERFICIELLES

Pr. Hocar • ~1.91 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF — dermatophytoses, candidoses, pityriasis versicolor

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Dermatophytes (generalites) :

- Champignons KERATINOPHILES → peau, poils (atteinte pilaire), ongles
- Dermatophytie de la peau glabre (herpes circine) : extension CENTRIFUGE, bordure vesiculeuse active, centre evolutif
- Intertrigo inter-orteil : 3e–4e espace ++, favorise par piscines, complique d'eczema dyshydrosique et d'erysipele (porte d'entree)
- ⚠️ ⚠️ *Les dermatophytes ne donnent PAS de localisation viscerale ni muqueuse (= candida)*

□ Vu : N2020, N2022, R2021

Teignes du cuir chevelu :

- MICROSPORIQUE : Microsporum (canis zoophile...), GRANDES plaques alopeciques, peu nombreuses, fluorescence VERTE a la lampe de Wood
- TRICHOPHYTIQUE : Trichophyton anthropophile, PETITES plaques multiples, cheveux casses a l'emergence, Wood NEGATIF
- FAVIQUE : T. schoenleinii, godet favique, alopecie CICATRICIELLE (definitive)
- Inflammatoire (kerion) : dermatophyte zoophile, possible fièvre, possible hors cuir chevelu ; les teignes tondantes guerissent a la puberte
- ⚠️ ⚠️ *Wood VERT = microsporique ; Wood negatif = trichophytique*

- ⚠️ La teigne favique ne guerit pas spontanément (alopecie cicatricielle)

□ Vu : N2020, R2021, R2024, Nov2024, N2025, N2026

Traitement des teignes :

- Griseofulvine PO 20 mg/kg/j x 6–8 semaines (≈ 250 mg x2/j pour 25 kg) + soins locaux (keratolytiques + antifongiques locaux)
- Coupe des cheveux autour des plaques, desinfection bonnets/peignes, eviction scolaire, recherche d'animaux infectes (zoophile)
- ⚠️ Pas de penicilline (infection fongique, pas bacterienne)

□ Vu : N2020, R2021, N2024

Candidoses (Candida albicans) :

- Favorisees par : diabete, maceration, protheses dentaires, contraceptifs oraux, corticotherapie, antibiotiques
- Atteignent : muqueuses (muguet, vulvovaginite = IST possible), grands plis (intertrigo), ONGLES des MAINS, langue noire villeuse
- ⚠️ Le candida ne donne PAS de teigne (= dermatophytes) ; ongles des mains (vs dermatophytes : pieds)

□ Vu : N2020, R2021, N2022

Pityriasis versicolor & folliculite pityrosporique (Malassezia) :

- Pityriasis versicolor : Malassezia furfur, favorise par hypersudation + climat chaud/humide ; macules chamois/brunatres/achromiques, fine desquamation
- Folliculite pityrosporique : papules/pustules folliculaires du dos/epaules (adulte d'age moyen) ; traitement ANTIFONGIQUE
- ⚠️ Diagnostic par examen mycologique direct (PAS le Tzanck)
- ⚠️ Folliculite pityrosporique traitee par antifongiques (pas antibiotiques)

□ Vu : R2021, N2024

Examen mycologique :

- Indispensable pour confirmer une dermatophytie ; AVANT tout antifongique
- Apres fenetre therapeutique : 4 semaines (antifongiques locaux), 3 mois (terbinafine) ; peau glabre → prelever la BORDURE active
- ⚠️ Ne pas prelever le centre de la lesion sur peau glabre (= bordure active)

□ Vu : R2021

[RANG 12] NUTRITION CLINIQUE

Pr. Baizri • ~1.91 Q/examen

□ □ Ref : PNNS · recomedicales.fr — nutrition / equilibre alimentaire

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Macronutriments vs micronutriments :

- MACRONUTRIMENTS = glucides, lipides, proteines → seules sources d'energie du corps
- MICRONUTRIMENTS = vitamines (liposolubles + hydrosolubles) + oligo-elements + mineraux ; non energetiques ; leur carence peut causer une maladie
- ⚠️ Les macronutriments ne sont pas les vitamines/oligo-elements
- ⚠️ Les micronutriments ne sont pas une source d'energie

□ Vu : N2020, R2021, N2024, Nov2024, N2025, N2026

Vitamines & valeurs caloriques :

- 13 vitamines au total ; LIPOSOLUBLES = A, D, E, K ; hydrosolubles = complexe B et C
- Valeurs caloriques : glucides 4 kcal/g, proteines 4 kcal/g, LIPIDES 9 kcal/g (10 g de lipides = 90 kcal)
- Exemple : 150 g glucides + 80 g protides + 100 g lipides = 1820 kcal

- **⚠ ⚠ La vitamine C est HYDROSOLUBLE (pas liposoluble) ; la K est liposoluble**
- **⚠ ⚠ Apports proteiques conseilles $\approx 0,8-1$ g/kg/j (pas 2 g/kg/j)**

□ Vu : R2019, N2019, N2020, R2021, N2021

Index glycémique (IG) & charge glycémique (CG) :

- IG a prendre en compte ; bas si < 55 , eleve si > 70 ; varie chez une meme personne selon fibres/lipides/proteines du repas
- IG du pain blanc $>$ pain complet/cereales ; glucides des legumineuses « meilleurs » (IG plus bas) que ceux du miel
- CHARGE glycémique = $IG \times (g \text{ de glucides}) / 100$; plus pertinente que l'IG ; basse ≤ 10 , elevee ≥ 20 (ex. IG 60 % $\times 40$ g = 24 $\rightarrow$ elevee)
- « Sucre » dans l'industrie alimentaire = saccharose
- **⚠ ⚠ IG 40/45/55 % = NON eleve ; un IG a 80 % est eleve**
- **⚠ ⚠ Densite nutritionnelle FAIBLE + densite energetique ELEVEE = malbouffe (fritures, soda, sans legumes)**

□ Vu : R2019, N2019, N2020, R2021, N2021, N2022, N2024, Nov2024, N2025, N2026

[RANG 13] OBESITE

Pr. Baizri • ~1.45 Q/examen

□ □ Ref : OMS (IMC) · recomedicales.fr — *obesite de l'adulte*

□ Correction officielle Normal 2024 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Definition & classification IMC (OMS) :

- Obesite = excès de MASSE GRASSE avec consequences nefastes pour la sante
- Surpoids 25–30 ; obesite moderee 30–35 ; severe 35–40 ; MORBIDE ≥ 40 (IMC 55 $\rightarrow$ morbide)
- Tour de taille = bon indicateur de l'obesite VISCERALE (androïde ♀ > 80 cm, ♂ > 94 cm)
- **⚠ ⚠ L'IMC ne renseigne PAS sur le type androïde/gynoïde (= tour de taille)**

□ Vu : R2019, N2024, R2024, Nov2024, N2025

Facteurs & causes secondaires :

- Facteurs : genetiques, troubles du comportement alimentaire, sedentarite, troubles emotionnels/psychologiques
- Obesites secondaires medicamenteuses : corticoides, neuroleptiques, antidepressseurs
- **⚠ ⚠ Rechercher une cause secondaire AVANT de conclure a une obesite essentielle**

□ Vu : N2024, R2024, Nov2024

Complications & bilan :

- Complications : prediabete, diabete, maladie coronaire, SAOS, HTA, dyslipidemie, atteinte articulaire (arthrose)
- Bilan systematique : HbA1c, bilan lipidique, recherche de SAOS, complications articulaires
- **⚠ ⚠ Arthrose (pas « polyarthrite ») ; pas de TDM abdominale systematique**

□ Vu : N2024, R2024, Nov2024

Traitement de 1re intention (obesite essentielle) :

- Correction des erreurs alimentaires + activite physique + soutien psychosocial + education therapeutique
- **⚠ ⚠ Pas de chirurgie en 1re intention ; pas de liposuccion/abdominoplastie (cosmetique, pas un traitement de l'obesite)**

□ Vu : N2024, R2024, Nov2024

[RANG 14] TOXIDERMIES MEDICAMENTEUSES

Pr. Bouhamidi • ~1.18 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF · CRPV — toxidermies graves (NET/SJS/DRESS/PEAG)

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Syndrome de Lyell (NET — necrolyse epidermique toxique) :

- Toxidermie GRAVE ; decollement cutane > 30 % (Lyell) [SJS < 10 %, overlap 10–30 %]
- Signe de Nikolsky POSITIF ; febrile ; dermatose bulleuse ; erosions muqueuses (cheilite, conjonctivite, « decollement en linge mouille »)
- Peut se compliquer de CECITE (sequelles oculaires)
- ⚠ ⚠ *N'est PAS photodistribue ; n'est pas une epidermolyse staphylococcique (= SSSS) ; n'epargne pas les muqueuses*
- ⚠ ⚠ *Le « < 10 % » correspond au SJS, pas au Lyell*

□ Vu : N2019, N2021, N2024, Nov2024, N2025

Erytheme pigmente fixe (EPF) :

- SEULE toxidermie EXCLUSIVEMENT medicamenteuse ; recidive au MEME site
- ⚠ ⚠ *Devant des ulcerations genitales a repetition d'origine medicamenteuse → EPF bulleux*

□ Vu : N2019, N2024, R2024, Nov2024, N2025

Toxidermies GRAVES & risque de cecite :

- Graves : NET/Lyell, Stevens-Johnson, DRESS (syndrome d'hypersensibilite), PEAG (pustulose exanthematique aigue generalisee)
- Risque de cecite : Lyell et Stevens-Johnson
- ⚠ ⚠ *Erytheme polymorphe MINEUR et simple photosensibilite ne sont pas des toxidermies graves*

□ Vu : R2019, N2026

Ce qui n'est JAMAIS une toxidermie :

- La dermatite atopique (constitutionnelle) n'est jamais un accident cutane medicamenteux
- ⚠ ⚠ *Psoriasis, eczema, EPF, erytheme polymorphe PEUVENT etre declenches/lies a un medicament — pas la dermatite atopique*

□ Vu : N2022

[RANG 15] ECZEMA (DERMATITE ATOPIQUE + ECZEMA DE CONTACT)

Pr. Hocar • ~1.09 Q/examen (9 + 3 fusionnees)

□ □ Ref : CEDEF — dermatite atopique / eczema de contact

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Dermatite atopique — clinique & topographie par age :

- Evolue par POUSSEES ; peut s'etendre sur toute la surface ; peut se compliquer de surinfection a HSV (Kaposi-Juliusberg)
- NOURRISSON : zones CONVEXES (joues, front, cuir chevelu, faces d'extension) — ENFANT (>2 ans, ex. 4 ans) : plis de FLEXION
- Diagnostic : atonie personnelle/familiale (asthme, rhinoconjonctivite allergique), lesions similaires des zones convexes du visage
- ⚠ ⚠ *Ne disparaît pas TOUJOURS a l'age adulte ; epargne la region perineo-fessiere*
- ⚠ ⚠ *Pas d'argument : ATCD de psoriasis, symptomatologie articulaire*

□ Vu : N2019, N2024, R2024, Nov2024, N2025

Dermatite atopique — traitement :

- Base OBLIGATOIRE : nettoyant surgras + emollients
- Poussees : dermocorticoides (activite moderee pour le visage/nourrisson)
- ⚠ ⚠ *Les dermocorticoides ne sont PAS interdits chez le nourrisson ; la vaccination n'est pas contre-indiquee*

□ Vu : R2024, Nov2024, N2025, N2026

Eczema de contact :

- Mécanisme = hypersensibilité RETARDEE de TYPE IV
- Allergène métallique le plus fréquent = NICKEL (pulpite des doigts, bijoux fantaisie) ; diagnostic = patch-tests
- ⚠️ Ce n'est PAS une allergie IgE de type I, ni un dépôt d'immuns complexes, ni une action toxique directe, ni phototoxique

□ Vu : N2022, N2026

[RANG 16] PRURIT

Pr. Aboudourib • ~0.82 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF — prurit (démarche étiologique)

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Traitement symptomatique du prurit :

- PHOTOTHERAPIE (UVB) ± antihistaminiques per os (prurit chronique)
- ⚠️ Pas d'hydrocortisone injectable, pas d'adrénaline SC, pas de dérivés cholinergiques, pas d'histamine PO (l'histamine donne le prurit)

□ Vu : N2019, N2024, R2024, Nov2024, N2025

Bilan d'un prurit généralisé sans dermatose :

- Bilan minimal : VS, créatinine, NFS, bilan hépatique, TSH, glycémie, calcémie (recherche d'une cause systémique)
- ⚠️ Pas d'échographie cutanée ni de prélèvement mycologique des ongles en 1^{re} intention

□ Vu : R2019, N2020

Orientations étiologiques clés :

- Prurit + asthénie + amaigrissement chez un sujet jeune → lymphome de Hodgkin (prurit paraneoplasique)
- Prurit + bulles tendues sur peau érythémateuse chez le sujet âgé → pemphigoïde bulleuse
- ⚠️ Un prurit chronique inexpliqué doit faire chercher une cause systémique/hématologique

□ Vu : R2021, N2026

[RANG 17] ACNE

Pr. Amal • ~0.73 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF · [recomedicales.fr](#) — acne

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Acne RETENTIONNELLE (microkystes/comédons, aspect luisant, sans inflammation) :

- Traitement = RETINOÏDE TOPIQUE SEUL (adapalène)
- ⚠️ Pas de cyclines ni d'antibiotique local pour une acne purement rétentionnelle

□ Vu : R2021, N2022, R2024, N2025, N2026 (réponse répétée)

Acne INFLAMMATOIRE / MIXTE :

- Papulo-pustuleuse diffuse : cyclines PO + rétinoïde topique (ou cyclines + peroxyde de benzoyl + rétinoïde topique)
- Mixte à prédominance inflammatoire : cyclines PO + peroxyde de benzoyl + rétinoïde topique
- Cyclines : minimum 3 mois, JAMAIS en monothérapie (toujours + rétinoïde topique)
- ⚠️ Pas d'antibiothérapie locale en monothérapie (résistances) ; cyclines pas « 6 mois » en routine
- ⚠️ Isotrétinoïne PO réservée aux formes sévères/nodulokystiques ou résistantes

[RANG 18] ECTOPARASIToses & TEIGNES DU CUIR CHEVELU

Pr. Hocar • ~0.55 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF — gale, pediculoses

□ Correction officielle Normal 2024 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Gale (Sarcoptes scabiei) :

- Prurit a recrudescence nocturne, contagé familial (fratrie qui se gratte), sillons + nodules scabieux ; nourrisson : pustules palmoplantaires
- Traitement (benzoate de benzyle) : application le SOIR, laisser poser, traiter TOUT l'entourage, désinfecter linge/literie
- « Gale des gens propres » : prurigineuse, pauci-lesionnelle (diagnostic difficile)
- ⚠ ⚠ La gale EST contagieuse (la « gale des gens propres » n'est pas non contagieuse)
- ⚠ ⚠ Eviter l'application le matin ; chez le nourrisson, soins particuliers (visage/cuir chevelu inclus)

□ Vu : R2019, N2020, N2021

Pediculose du cuir chevelu (poux) :

- Prurit du cuir chevelu/nuque + lentes (petits corps gris ovoïdes fixes latéralement au cheveu) + folliculite + adenopathies cervicales
- Pediculus pubis (morpion) : peut être une IST
- ⚠ ⚠ Devant un prurit du cuir chevelu de l'enfant avec lentes → pediculose

□ Vu : R2019, N2020, N2021

Teignes (rappel — voir aussi Mycoses) :

- Microsporique : grandes plaques, Wood VERT ; trichophytique : petites plaques multiples, Wood négatif
- Folliculite pityrosporique : papulo-pustules folliculaires du dos/épaules
- ⚠ ⚠ Les teignes sont des dermatophytoses (traitement = griseofulvine, pas antibiotique)

□ Vu : N2021, N2022, N2024

[RANG 19] ERYTHEME NOUVEUX

Pr. Aboudourib • ~0.36 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF — erythème nouveau (démarche étiologique)

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Sémiologie :

- Nouées DOULOUREUSES, BILATÉRALES, face ANTERIEURE des jambes, SANS ulcération ni nécrose (dermo-hypodermite)
- ⚠ ⚠ Pas de bulles à Nikolsky+ (= bulleuse), pas de nodules ulcérés chroniques, pas de papules purpuriques nécrotiques

□ Vu : N2026

Étiologies & syndrome de Löfgren :

- Étiologies : infection streptococcique (post-strep), SARCOIDOSE, tuberculose (primo-infection), MICI (Crohn, RCH), médicaments, Yersinia, Behçet
- Syndrome de LOFGREN = érythème nouveau + adenopathies hilaires/médiastinales bilatérales + arthralgies + fièvre → sarcoidose aiguë
- ⚠ ⚠ Ni syphilis secondaire, ni syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, ni psoriasis

□ Vu : N2019, N2022, R2024, N2025

[RANG 20] TUBERCULOSE CUTANEE

Pr. Aboudourib • ~0.27 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF · PNLAT Maroc — tuberculose cutanee

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Generalites :

- Evolution chronique et lente ; certaines formes mutilantes/cicatricielles ; l'immunodepression favorise les formes etendues/disseminees
- ⚠️ *N'est pas TOUJOURS secondaire a une atteinte pulmonaire active ; la guerison spontanee n'est pas frequente*

□ Vu : N2026

Formes cliniques :

- Tuberculose verruqueuse : contamination professionnelle/accidentelle ou auto-inoculation ; IDR fortement positive
- Gomme tuberculeuse : immunodeprime/denutri, membres inferieurs, abcès qui se ramollit puis s'ulcere (laisse une cicatrice)
- ⚠️ *Traitement = antibacillaires standard (phase intensive de 4 antibacillaires 2 mois puis 2 antibacillaires) — « 4 antibacillaires pendant 6 mois » est inexact*

□ Vu : N2019, N2021

[RANG 21] PSORIASIS

Pr. Amal • ~0.27 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF · recomedicales.fr — psoriasis

□ Correction officielle normal 2025 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Medicaments AGGRAVANTS :

- Beta-bloquants, antipaludeens de synthese, IEC, lithium, AINS
- ⚠️ *Le methotrexate et la ciclosporine TRAITENT le psoriasis (ne l'aggravent pas) ; les inhibiteurs calciques ne l'aggravent pas*

□ Vu : N2021, N2024

Indications du traitement SYSTEMIQUE :

- Atteinte etendue (> 10 % surface corporelle), rhumatisme psoriasique, psoriasis pustuleux generalise, erythrodermie, retentissement majeur
- Topique 1re intention : dermocorticoides + analogue de vitamine D
- ⚠️ *Le seuil n'est pas « > 3 % de surface » (≈ 10 %)*

□ Vu : N2025

[RANG 22] URTICAIRE

Pr. Bouhamidi • ~0.18 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF — urticaire aigue/chronique

□ Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Urticaire superficielle :

- Papules OEDEMEATEUSES FUGACES (< 24 h), PRURIT frequent, oedeme dermique, SANS cicatrice residuelle
- ⚠️ *Des lesions > 48 h ou laissant une cicatrice → vascularite urticarienne (pas une urticaire simple)*

□ Vu : N2026

Etiologies / facteurs declenchants :

- Infestation parasitaire, hepatite virale, médicaments, froid, effort, aliments, infections
- ⚠️⚠️ *L'urticaire chronique (> 6 semaines) est le plus souvent idiopathique*

□ Vu : N2022

[RANG 23] LEPRE

Pr. Aboudourib • ~0.18 Q/examen

□ □ Ref : CEDEF · OMS — lepre (*Mycobacterium leprae*)

□ Correction officielle normal 2021 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Lepre lepromateuse (multibacillaire) :

- > 20 lesions, topographie SYMETRIQUE bilaterale, facies LEONIN, madarose (alopecie des queues des sourcils), tres contagieuse
- ⚠️⚠️ *N'atteint pas electivement l'enfant ; atteinte neurologique symetrique/tardive (severe asymetrique = tuberculoide/borderline)*

□ Vu : N2021

Formes tuberculoide & borderline :

- Tuberculoide (paucibacillaire) : peu de lesions hypochromiques anesthesiques a limites nettes, atteinte nerveuse severe asymetrique
- Borderline-borderline : lesions annulaires, intermediaires
- ⚠️⚠️ *Les plaques infiltrées anesthesiques a limites nettes orientent vers une forme tuberculoide*

□ Vu : N2019

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~1.1% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

Topics hors programme 2026 (par fréquence décroissante) :

Topic (hors programme)	Total	Moy/exam
HTA endocriniennes (HTA secondaire d'origine endocrinienne)	6 Q	0.55

[HORS 1] HTA ENDOCRINIENNES

6 questions — 0.55 Q/examen (apparue jusqu'en 2026) — HORS liste 2025–26

Quand suspecter une HTA secondaire :

- Age JEUNE de survenue (< 30 ans), HTA SEVERE d'emblee, HTA RESISTANTE (tri/quadrithérapie), hypokaliémie, symptômes paroxystiques
- ⚠ ⚠ Ni le sexe, ni le simple besoin d'un IEC ne sont des arguments

□ Vu : N2022, N2026

Causes endocriniennes d'HTA :

- Acromégalie, syndrome de Cushing, hyperaldostéronisme primaire (Conn), pheochromocytome ; dysthyroïdies
- ⚠ ⚠ Cushing et acromégalie sont au programme (leçons dédiées) ; Conn et pheochromocytome ne le sont pas en 2025–26

□ Vu : N2022

Hyperaldostéronisme primaire (Conn) & pheochromocytome :

- Conn : HTA + HYPOKALIEMIE profonde ; aldostérone ELEVEE + renine BASSE (rapport élevé) ; causes : hyperplasie bilatérale, adénome de Conn
- Pheochromocytome : diagnostic = METANEPHRINES (dérivés méthoxyles) URINAIRES ; triade céphalées-sueurs-palpitations + HTA paroxystique
- ⚠ ⚠ Pheochromocytome : pas le dosage d'adrénaline plasmatique de 8h ni le CLU

□ Vu : N2022

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS DERMATOLOGIE & ENDOCRINOLOGIE

** CLASSIFICATIONS & SEUILS A MEMORISER **

Diabete	GAJ $\geq 1,26$ g/l · gly aleatoire ≥ 2 · HbA1c $\geq 6,5$ %
Prediabete	GAJ 1,10–1,25 · HbA1c 5,7–6,4 % · HGPO-2h 1,40–1,99
Diabete gestationnel	GAJ $\geq 0,92$ g/l (HGPO 75g, 24–28 SA)
Adenome hypophysaire	Micro < 10 mm · Macro ≥ 10 mm (IRM)
Obesite (IMC)	Surpoids 25–30 · Moderee 30–35 · Severe 35–40 · Morbide ≥ 40
Tour de taille (androide)	Femme > 80 cm · Homme > 94 cm
Nodule thyroïdien	EU-TIRADS · cancer ≈ 5 % · cytoponction T5 >5 mm / T4 >10 mm / T3 >20 mm
Lyell / SJS	NET (Lyell) > 30 % · SJS < 10 % · overlap 10–30 %
Index / charge glycémique	IG bas < 55 , eleve > 70 · CG = IG x g/100 (bas ≤ 10 , eleve ≥ 20)
Calories des macronutriments	Glucides 4 · Proteines 4 · Lipides 9 kcal/g

** LE BON EXAMEN AU BON MOMENT — TESTS & MARQUEURS CLES **

Marqueur / Critère	Indication
IRM hypophysaire	Examen de reference de l'adenome hypophysaire
ACTH plasmatique	Cushing confirme → localisation : ACTH haut/N = dependant ; ACTH bas = surrealien
CLU/24h + cortisol minuit + freinage minute	Confirment l'hypercorticisme ($\neq$ cortisol de 8h)
ACTH eleve + cortisol 8h bas	Insuffisance surrenalienne peripherique (Addison)
Synacthene / hypoglycémie insulínique	Insuffisance surrenale si cortisol 8h non franchement bas
GH non freinee sous HGPO + IGF-1	Diagnostic de l'acromegalie
Prolactinémie de base (1 dosage)	Hyperprolactinémie ($\neq$ test TRH)
Couple TSH / LT4 (puis LT3)	Diagnostic de thyrotoxicose
Ac anti-recepteurs TSH + Thyroid inferno	Maladie de Basedow
Scinti I123 : hyperfixation localisee + extinction	Nodule chaud toxique
Aldosterone elevee / renine basse	Hyperaldosteronisme primaire (Conn)
Metanephrines urinaires	Pheochromocytome
TPHA (specifique) / VDRL (suivi, non specifique)	Syphilis — VDRL+ / TPHA– = FAUX positif
Charge virale VIH	Primo-infection VIH (Western blot encore negatif)
Histo bulle + IFD peri-lesionnelle	Dermatoses bulleuses auto-immunes
Lampe de Wood : VERT	Teigne microsporique (trichophytique = Wood negatif)
Lampe de Wood : ROUGE corail	Erythrasma (Corynebacterium)

Marqueur / Critère	Indication
Test au monofilament (10 g)	Depistage de la neuropathie diabetique

**** PIEGES CLASSIQUES DU CONCOURS (les FAUX qui font perdre des points) ****

- **⚠ Prolactinome (meme macro) → traitement MEDICAL (agonistes dopaminergiques), JAMAIS chirurgie en 1re intention**
- **⚠ VDRL+ / TPHA- = FAUX POSITIF (pas une syphilis latente) ; chez la femme enceinte a examen normal → rassurer**
- **⚠ Maladie d'Addison & insuffisance cardiaque ne sont PAS des causes de diabete secondaire**
- **⚠ Pan-hypopituitarisme = hypothyroidie CENTRALE (pas peripherique)**
- **⚠ La CREPITATION dans une dermo-hypodermite = fasciite necrosante (jamais dans l'erysipele simple) ; AINS interdits**
- **⚠ Cortisol de 8h SEUL ne confirme jamais un Cushing (rythme circadien)**
- **⚠ Pemphigus = INTRA-epidermique / Nikolsky+ ; Pemphigoide = SOUS-epidermique / Nikolsky- / sujet age**
- **⚠ Keratoses actiniques → carcinome EPIDERMOIDE (pas CBC, pas melanome) ; keratose seborrheique = benigne**
- **⚠ Melanome = malignite GENERALE (metastase) ; au Maroc siege plantaire ; atteint les ongles**
- **⚠ Acne purement retentionnelle (microkystes/comedons) → retinoide topique SEUL (pas de cyclines)**
- **⚠ Beta-bloquants, antipaludeens et IEC AGGRAVENT le psoriasis ; methotrexate/ciclosporine le TRAITENT**
- **⚠ Eczema de contact = hypersensibilite RETARDEE type IV (nickel) ; pas une allergie IgE**
- **⚠ Vitamine C = HYDROSOLUBLE ; liposolubles = A, D, E, K**
- **⚠ Insulinoresistance ne concerne PAS la medullosurrenale/cerveau ; au foie elle AUGMENTE la neoglucogenese**
- **⚠ Le traitement preventif de l'herpes : > 6 recurrences/an (pas > 3), non contre-indique chez la femme enceinte**
- **⚠ Addison : regime NORMOSALE + hydrocortisone + fludrocortisone (jamais de potassium per os : deja hyperkaliemie)**

**** ARBRES DECISIONNELS & ENCHAINEMENTS CLES ****

- **Hypercorticisme : CONFIRMER (CLU/24h + cortisol minuit + freinage minute) → LOCALISER (ACTH) → ACTH haut = corticotrope/ectopique (IRM hypophyse + TDM thorax) · ACTH bas = surrealien (TDM surrenales)**
- **Adenome hypophysaire : IRM → taille (micro/macro) → bilan hormonal → si prolactinome = agonistes dopa · si Cushing/acromegalie/compressif = chirurgie**
- **Glycemie elevee a l'admission (SCA/IDM) → reevaluer a distance : normalisation = stress/HMJ/IGT · HbA1c ≥ 6,5 % = diabete revele**
- **Thyrotoxicose : couple TSH/LT4 (dg positif) → etiologie : anti-RTSH + Doppler (Basedow) · scintigraphie (nodule chaud)**
- **Nodule thyroïdien : echo + EU-TIRADS + TSH → TSH basse = scintigraphie · cytoponction selon score x taille**
- **Ulceration genitale : INDOLORE induree = syphilis (TPHA-VDRL) · DOULOUREUSE purulente = chancre mou · recidivante = herpes/aphte/EPF**
- **Dermo-hypodermite de jambe : fièvre + placard + porte d'entree = erysipele (penicilline G) ; douleur/necrose/crepitation = fasciite (urgence chirurgicale)**
- **Bulles : FLASQUES + muqueuses + Nikolsky+ = pemphigus · TENDUES + prurit + sujet age + Nikolsky- = pemphigoide (dermocorticoides) · faces d'extension + IgA = dermatite herpetiforme (disulone)**
- **Pied diabetique : neuropathie + arteriopathie + microtrauma + infection → ulcere indolore (neuro) vs douloureux/necrose (arteritique)**

Généré par Claude.ai (claude-opus-4.x) — Version 1

Cross-match 550 QEs officielles × Cours AIO Dermato + Endocrino 2026 · Corrections officielles e-qe.online

**Endocrino : Pr Elmghari · Pr Ansari · Pr Baizri — Dermato : Pr Bouhamidi · Pr Amal · Pr Aboudourib · Pr Hocar —
FMPM 2025–26**

Améliorations Version 1 :

- ✓ 550 QE de 11 sessions FMPM (2019 → normal 2026) analysées, dédoublées et classées par fréquence
- ✓ Leçons fusionnées intelligemment (axe corticotrope, eczéma, IST) selon la liste officielle 2025–26
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang ; FAUX explicites avec Δ (le plus haut rendement pour le concours)
- ✓ Liens cliquables vers les corrections officielles e-qe.online par session
- ✓ HTA endocrinienne placée en PARTIE 4 (hors liste 2025–26) avec disclaimer
- ✓ Aide-mémoire transversal : seuils, le bon examen au bon moment, pièges, arbres décisionnels